



جوستاف روسي انترناشيونال - مصر (EPE) * طلب علاج أول مرة / متكرر

إسم المريض ربيعاً : سعديه عبدالحميد محمد برين

المحافظة : الجيزه الحي / المدينة : اخري

العنوان : 5ش بلال بن رباح قريه

عبدالصمد منشاة القناطر الجيزة

تاريخ تسجيل الإستمارة : 05-10-2026

رقم البطاقة : 25210142101245 رقم التليفون : 01017500836

العمر(تاريخ الميلاد) : 14-10-1952 المهنة : ربه منزل

الإقرار

أقر انا الموقع أدناه انني لا اتمتع باي نظام علاج مثل:-التأمين الصحي-القوات المسلحة-الشرطة-الهيئات-المؤسسات او اي نظام يتعارض مع نظام العلاج علي نفقة الدولة- وسوف اتحمل كافة نفقات العلاج في حالة ثبوت غير ذلك

الإخصائي الاجتماعي (.....) التوقيع: (.....)

المقرر بما فيه التوقيع: (.....)

التشخيص الإكلينيكي : سرطان بالثدي (مبادرة)

نتائج الأبحاث : (مرفق)

التشخيص النهائي : سرطان بالثدي (مبادرة)

خطة العلاج : علاج مبادرة سرطان الثدي علاج تدعيمي وتلطيفي [6579] قسم العلاج : الاورام

التعليق على التشخيص :

تقرير اللجنة الثلاثية المتخصصة

الاسم : د/محمد كيلاني الوظيفة : التوقيع :
الاسم : د/ندى حسن الوظيفة : التوقيع :
الاسم : د/نرمين رمضان الوظيفة : التوقيع :

أطلعت اللجنة علي لائحة العلاج الخاصة بالمجالس وتلتزم جهة العلاج بلائحة المجالس الطبية. كما تقرر اللجنة بأن البيانات المدونة في هذا النموذج صحيحة.

تعتمد صحة الأبحاث والمرفقة رئيس اللجنة ومدير المستشفى.

تتعهد المستشفى أن لا يتم تنفيذ القرار إلا بعد مراجعة الملف الطبي للمريض وإعادة مناظرة المريض بالمستشفى قبل الصرف.

أعضاء اللجنة

أ.د. /د. /د. /د.

قرار اللجنة

التشخيص النهائي :
خطة العلاج :
المستشفى :
جهة العلاج :
ملاحظات :
قسم :
نفقات :

ختم
شعار الجمهورية

مدير عام
مديرية الشؤون الصحية

رئيس
المجلس الطبي المتخصص

--

Name: سعاديه عبدالحميد محمد بن National ID: 25210142101245	
---	---

تقرير طبي

السيد
تحية طبية وبعد,,

إيماء للطلب المقدم من	بشأن تقرير طبي للمريض
بقسم:	رقم طبي:

نتشرف بان نوضح فيما يلي تقريرنا عن حالته
--

تاريخ وساعة الدخول : -- --:-- yyyy-mm-dd	تاريخ وساعة الخروج : PM 01:17 05-07-2026
---	---

وبعد الكشف والفحوصات والمتابعة وجد انه
--

المریضة تعاني من ورم غير حميد بالثدى و تحتاج الي Supportive and palliative Treatment
--

التاريخ : 05-07-2026	الوقت : -- --:--
	الطبيب المعالج : د/شيماء لاشين

جمهورية مصر العربية
بطاقة تحقيق الشخصية

سعدية
عبد الحميد محمد برين
هش بلال بن رياح فورية عبدالصمد
منشأة القناطر - الجيزة

١٩٥٢/١/١٤ ٢٥٢١٠١٤٢١٠١٢٤٥

JV2435301

٢٠٢٣/٠١ ٢٥٢١٠١٤٢١٠١٢٤٥

عاملة زراعية

انثى مسلمة أرملة

البطاقة سارية حتى ٢٠٣٠/٠١/٠١

١



رسوم الاستعلام 20 جنية

تاريخ الاصدار : 2026-6-2

جهة الاصدار : فرع الجيزة

الى من يهمه الامر

الهيئة العامة للتأمين الصحي تعمل من خلال قوانين منظمة للتأقاع الخاضعين لقانون التأمين
الاجتماعى رقم 79 لسنة 1975 المعدل بالقانون 25 لسنة 1977 "القوى العاملة والمعاشات
والارامل " وكذلك قانون 99 لسنة 1992 الخاص بطلاب المدارس و قانون رقم 86 لسنة 2012 "
الاطفال دون السن المدرسى" وقانون رقم 23 لسنة 2012 الخاص بالمرأة المعيلة .
وطبقا لقاعدة البيانات المرسله من التأمينات الاجتماعيه
وطبقا لقاعدة البيانات المرسله من الضمان الاجتماعى
والبحث تبين أن

السيد (ة) سعديه عبدالحميد محمد برين بطاقة رقم 25210142101245
تليفون رقم: لا يوجد

وطبقا الى خطاب من التأمينات الاجتماعيه يفيد عدم الانتفاع
يعتبر من الفئات غير المنتفعه بالتأمين الصحى صدر هذا الخطاب دون ادنى مسنولية على الهيئة
العامة للتأمين الصحى حال خضوع المواطن لقانون التأمين الصحى الشامل
وشكرا

تاريخ الطباعة : 2026-6-2

الموظف المختص

احمد ياسر



مسلسل 1986399

الخطاب سارى لمدة ثلاثة أشهر من تاريخ الإصدار. (لا فى حالة تغيير الخالة المواطن من قبل الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية أو
وزارة التضامن الاجتماعى أو وزارة التربية و التعليم

الادارة المركزية لتنظم المعلومات و التحول الرقمى

Name:	سعدية عبدالحميد محمد برين	
MR. :	12100	
Detailed Medical Report		
		السيد
تحتية طبية وبعد,,		
	بشأن تقرير طبي للمريض	
	رقم طبي:	
بقسم:		
إيماء للطلب المقدم من		
ننشرف بأن نوضح فيما يلي تقريراً عن حالته		
	تاريخ وساعة الخروج :	
تاريخ وساعة الدخول :		
وبعد الكشف والفحوصات والمتابعة وجد انه		
MDT discussion for TCHP (Taxol 60 mg/M² + carboplatin AUC 2) 18 weeks, 6 cycles planned. 77 years old, hypertension, cT4B N2 M0 breast cancer; NACT followed by left total mastectomy. MDT recommended TCHP (Taxol weekly with carboplatin 18 weeks) 6 cycles. Labs completed and accepted; echo on 27/7 showed EF 61 %. Weight 55 kg, height 159 cm. First cycle (c1 w1) of Taxol and carboplatin AUC 2 with 20 % dose reduction due to age and frailty; escalation considered if tolerated. For c1 phesgo 1200/600 if approved. 7/2026 MDT: TCHP (Taxol weekly with carboplatin 18 weeks) 6 cycles. Week 2: TC + C1 PHESGO. Week 3 + 4: IN PH. Post-mastectomy left breast cancer CT3 N1 M0 IDC, ER 8/8, PR 2/8, HER2 3+, Ki-67 80 %. Left breast mass 4.8 × 2.9 cm, 3-4 o'clock, ipsilateral axillary lymph nodes, suspected intraductal extension. EF 61 % on 27/7. For c1 loading phesgo 1200/600, week 4 Taxol 115 (75 mg/m²) carboplatin AUC 1.5; neoadjuvant and assess tolerability. On exam, left breast mass 3 × 3 cm (decreased). Grade 2-3 fatigue; consider same dose if still poorly tolerated. Next week to omit carboplatin for week 5 Taxol 115 carboplatin AUC 1.5 and liver support (ALT 56). The patient has completed 5 cycles of the TCHP regimen to date.		
تحريراً في ,		
	الوقت :	
19-09-2026		: التاريخ
dina makram		: الطبيب المعالج
يعتمد ,		

PATHOLOGY DEPARTMENT HISTOPATHOLOGICAL REPORT

Patient name: سعيه عبدالحميد محمد

Age: 74years

Sex: female

Request type: مبادره

Sub request type:

Hospital no:

Pathology no.:460-2026

Department: صحنه مرأه

Date of result:11/6/2026

Referred by: د/مروه حسن

Date of biopsy:1/6/2026

Nature of specimen: tru-cut biopsy

I.D. Number:25210142101245

Clinical diagnosis: Left breast masa

Gross pathology :

Multiple grayish white tissue cores 0.5x0.5cm, totally submitted.

Immunohistochemical technique: Sections were prepared from the paraffin block, processed in Benchmark Ultra machine (Ventana) and stained by rabbit monoclonal antibodies using Ultra view HRP DAB as chromogen and hematoxylin as counter-stain. The sections were treated against: Ecadherine -ER-PR- Her2- Ki67.

Microscopic picture:

Microscopic examination revealed mammary core tissue showed malignant growth formed of tubules, clusters, nest and cribriform pattern of anaplastic ductal cells with marked anaplasia and mild tendency to form tubules dispersed among desmoplastic stroma with mild lymphocytic response. Also seen focal ductal carcinoma insitu intermediate grade, cribriform pattern.

Immunohistochemistry:

Ecadherine: diffuse positive in tumor cells

ER: Strong nuclear staining in 80% of tumor cells (Allred Score 8/8).

PR: Weak nuclear staining in < 1 % of tumor cells (Allred Score 2/8).

Her2: Strong complete membranous staining of >10% tumor cells (score 3+) Positive

Ki67: Positive nuclear staining of 80% of tumor cells.

Diagnosis: Left breast mass Tru-Cut Biopsy:

Invasive duct carcinoma, Grade III

Signature:

Dr.Nermine Nabil.M.D

Dr.Mona Mohamed.M.D

Pathology Lab. Manager

BASMA REFAAT M.D

Patient ID: 95837	Patient Name English: Sadeiah Abdalhamid Mohamed Brin
٧٣ سنة، ٧ شهر Age:	2026/05/25 10:14:49 AM :Report Date

Women's Health Outreach Program

Bilateral Full field Digital Mammography and high-resolution ultrasound.

Clinical summary: 72years old female patient with left breast lump.

Detailed Findings

Left breast:

- Scattered fibro glandular densities (ACR density B).
- The left breast shows UOQ large ill-defined spiculated dense mass lesion with obscured margins and superimposing pathological microcalcifications .
- **Ultrasound** revealed large ill defined hypoechoic mass lesion measures about 4.8 x 2.9 cm at its maximum diameters and located at 3-4 ° clock position. (Index lesion).
- Another smaller lesion 1x0.6cm seen retroareolar with 3cm distance apart from the index lesion
- An adjacent prominent duct seen connecting from the lesion till the nipple
- Normal nipple/areolar complex.
- Multiple enlarged axillary lymph nodes at level I, with effaced hila, largest one measures about 14x10 mm at level I.

Right breast:

- Scattered fibro glandular densities (ACR density B).
- No masses, asymmetric densities, distortion or suspicious clusters of micro calcifications.
- **Ultrasound** demonstrated prominent glandular elements of the breast tissue with mottled appearance.
- Normal skin/subcutaneous tissue and nipple/areolar complex.
- Non-specific axillary LNs.

Impression:

- **Left breast (BIRADS 5):** UOQ malignant mass lesion with ipsilateral pathological axillary lymph nodes and suspected intraductal extension as described. For tru cut biopsy
- **Left breast (BIRADS 2):** FIBROADENOSIS .

Much obliged,
Dr. MARWA A. EL SEOUD

Name: Saadeya Abd El-Hameed Mohammed

Referred by Prof Dr مستشفى هرمل

Date: 02/07/2026

POST CONTRAST CT SCAN OF THE CHEST , ABDOMEN AND PELVIS WITH CORONAL RECONSTRUCTION: -**i. Chest:**

- Left breast shows an ill-defined enhancing soft tissue mass with diffuse skin thickening and trabecular edema suspicious for dermal lymphatic invasion. No definite invasion of the pectoralis major muscle is identified. It measures about 3.5 x 3 cm at maximum axial dimensions.
- Multiple pathologically enlarged left axillary lymph nodes are noted, showing rounded configuration, loss of fatty hilum, and heterogeneous enhancement, consistent with metastatic nodal disease. The largest measures about 8 mm at maximum diameter
- No right axillary, supraclavicular, or internal mammary lymphadenopathy.
- Lung parenchyma is clear with no focal nodules or masses.
- No pleural effusion.
- No mediastinal or hilar lymphadenopathy.

ii. Abdomen:

- Liver is normal in size and enhancement with no focal lesions.
- Gallbladder, biliary tree, spleen, pancreas, adrenal glands, and kidneys are unremarkable.
- No abdominal or retroperitoneal lymphadenopathy.

iii. Pelvis:

- Pelvic organs appear unremarkable.
- No pelvic lymphadenopathy.

iv. Bones:

- No focal lytic or sclerotic lesions to suggest osseous metastasis.

Impression:

- Left breast carcinoma with diffuse skin thickening suggestive of locally advanced/inflammatory breast cancer.
- Metastatic left axillary lymph nodes.
- No CT evidence of distant metastatic disease.

Yours,

Dr. Yahya Khalifa ,Msc,FEBR



Name : Sadia Abdul Hamid

Date : 08-07-2026 07:29

Branch : Dokki

Medical No. : 411434

Ref.Physician Prof : Goustav Roussey Egypt

Ins.Company : Walkin

Whole-Body Bone Scintigraphy Report

Clinical History

- A 74-year-old female patient with a known history of left breast carcinoma presents for skeletal staging due to recent generalized bony aches.
- This is the baseline bone scan.

Technical Procedure

- Whole-body anterior and posterior skeletal imaging was performed approximately 2–3 hours following the intravenous injection of Tc-99m MDP.

Description

- Axial Skeleton: Normal, symmetric tracer localization throughout the calvarium, facial bones, and entire vertebral column. The ribs and sternum show homogeneous uptake without focal costal lesions or asymmetrical tracer clusters.
- Appendicular Skeleton: Both pelvic bones, sacroiliac joints, and proximal femora exhibit uniform radiotracer uptake. Mild, bilaterally symmetric periarticular tracer enhancement is seen in both shoulders and knees. No focal, asymmetric "hot spots" suspicious for osteoblastic malignancy are observed anywhere in the skeleton.
- Soft Tissues & Excretion: Normal physiological soft-tissue background clear. Both kidneys are visualized symmetrically with regular excretion into the urinary bladder.

Impression

- No Evidence of Osteoblastic Metastasis: Negative baseline whole-body bone scan for active secondary osseous localization.

Much oblige
Dr. Alaa Nagi, MD
Nuclear medicine

Patient ID:2026-07-27-0002

Sonographer:

Sex:Female

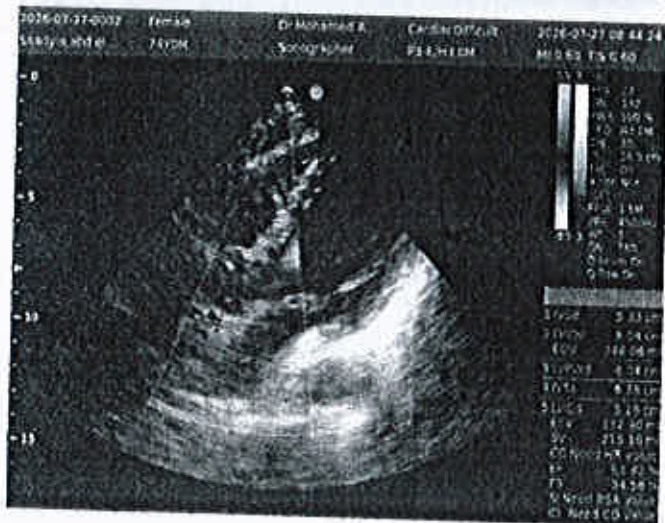
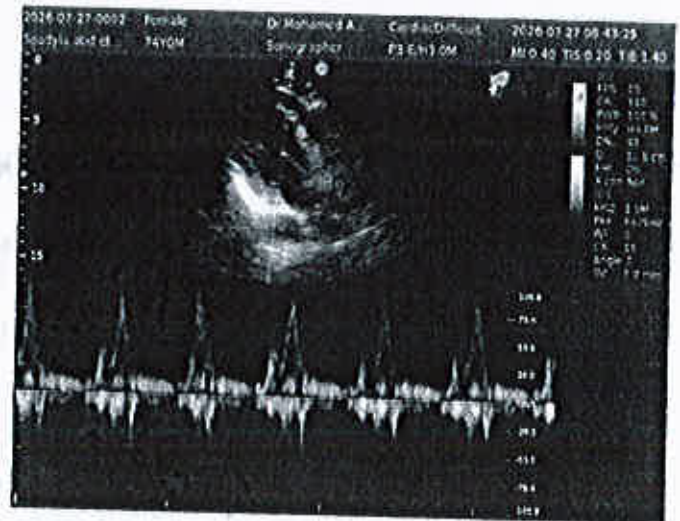
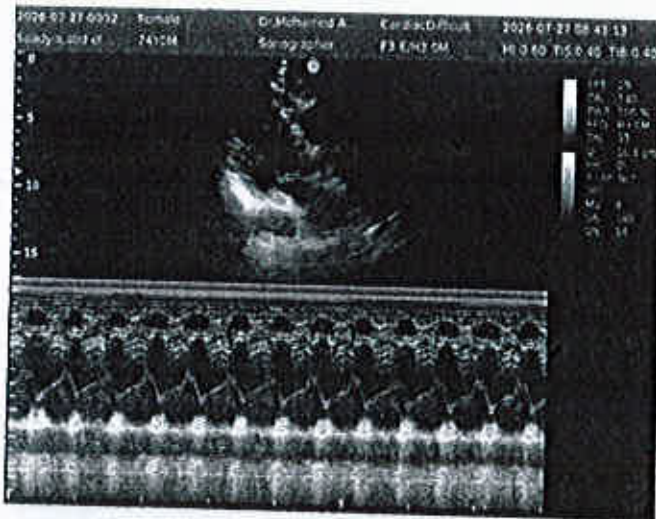
Hospital:Dr.Mohamed Aly Heart Center

Patient Name:Saadyia,abd elhameed mohamed

Birthday:1952-07-01

Age:74

Study Date:2026-07-27





Dr. Mohamed Aly Heart Center
Cardiology Report

Patient Name: Saadyia, abd elhameed
mohamed

Age: 74

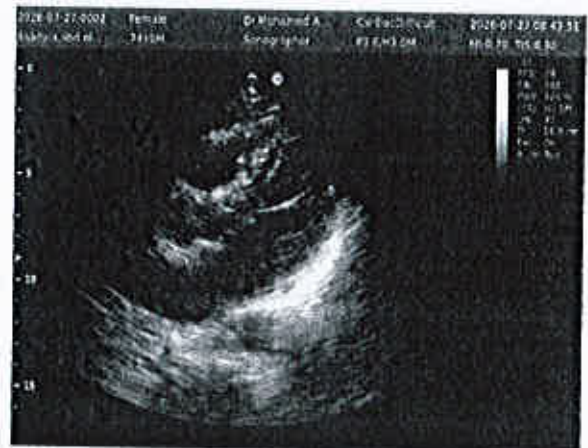
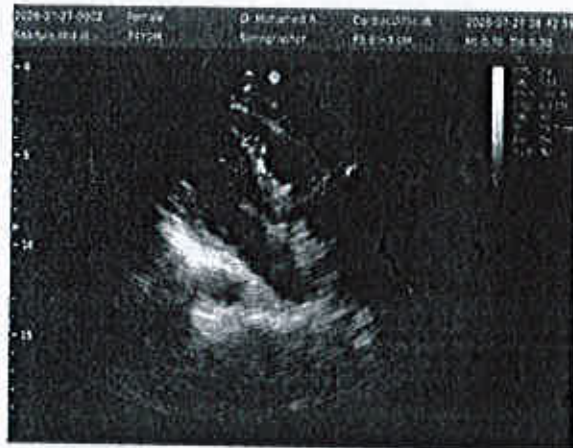
Sex: Female

Patient ID: 2026-07-27-0002

Diagnostic

IVSd	5.33 cm Min	LVIDs	5.26 cm Min
LVIDd	8.04 cm Min	ESV	132.90 ml
EDV	348.06 ml	SV	215.16 ml
LVPWd	4.04 cm Min	EF	61.82 %
IVSs	6.38 cm Min	FS	34.56 %

Ultrasound Image:



Description

impairment of left ventricular internal dimension, e`EF:61.8%
dilated left ventricle, diastolic dysfunction grade I
no RWMA detected
mitral valve: mild stenosis, mild regurge
aortic valve: sclerotic, normal flow
normal rt. side internal dimension & valves and systolic function
no intracardiac thrombi
no pericardial effusion

Doctor's signature (or stamp)

Date
C. 27 / 7 / 2026